

Información Paciente

Nombre : Gladys Del Rosario Garrido Rivera	Rut : 8.186.200-1	N° Archivo : 2426916	N° Epicrisis : 469419
Edad : 67a 5m 3d	Fecha Nacto : 27/08/1958	Sexo : Femenino	
Dirección : Pje Puerto Punta Arenas 3788 Villa Andes	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 936167459	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)	Fecha Ingreso : 24/12/2025 00:05	Días Estadía : 37
Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía	Fecha Egreso : 30/01/2026 15:01	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha de ingreso CASR: 23/12/25
Fecha de ingreso UTIM: 24/12/25
Fecha de ingreso UCI: 28/12/25
Fecha de ingreso UTAC 08/01/26
Fecha de ingreso a sala: 25/01/26

Lateralidad y funcionalidad desconocida, con los siguientes antecedentes:

- Médicos: HTA, DM2 IR, Dislipidemia, Miopatía necrotizante Anti HMGCR (+) debut 2024
- Fármacos: Azatioprina 50 mg cada 8 horas VO, Amitriptilina 25 mg cada 24 horas VO, Sertralina 50 mg cada 24 horas, Insulina NPH 16 AM ¿ 6 PM, Losartán 50 mg cada 24 horas, Amlodipino 10 mg cada 24 horas
- Hospitalizaciones recientes: Niega
- Quirúrgicos: Niega
- Alérgicos: Niega
- Tóxicos: OH (-) TBQ (-) Drogas (-)
- Social: Independiente para ABVD.

HISTORIA CLÍNICA

Consultó el 23/12/25 por 5 días de mareos y compromiso del estado general. Refieren tuvo caída a nivel con golpe en cadera derecha motivo por el que se controla exámenes con neuróloga tratante y deriva al SU por pancitopenia.

Ingresó en regulares condiciones generales, normotensa, taquicárdica, saturación límite (FC:105 PA:127/61 T:36°C SAT:92% amb). Al examen físico desorientada e inatenta, bien perfundida, con fuerza M5 en EESS y EEII. En exámenes de ingreso destacó pancitopenia (GB:1.800 Hb:3.5 VCM:96 HCM:34 RAN:700 PLQ 116.000), y leve alteración de pruebas hepáticas (BT:1.66 BD:0.73 FA:116 GGT:187 GOT:49 GPT:33), LDH elevada 453, sin falla renal, CKT de ingreso 227 previa en 174, sin coagulopatía. Se estudió con un TAC TAP al ingreso donde destacó engrosamiento parietal anular estenosante en colon sigmoides distal sospechoso de colitis segmentaria vs neoplasia epitelial. Se transfunden 3 UGR e ingresó a UTIM.

Diagnósticos de ingreso:
Pancitopenia en estudio
Antecedentes

Evolución durante hospitalización

Hemodinamia:

Ingresó inicialmente a UTI, sin embargo, requirió intubación por compromiso de conciencia por lo que fué trasladado a UCI donde ingresó inicialmente inestable hemodinámicamente, con requerimientos bajos a moderados de NAD hasta 06/01. Posteriormente no fué conflicto.

Respiratorio

Requirió VMI el 28/12 en relación a compromiso de conciencia mencionado, con episodio de aspiración que tras ser tratado no interfirió con weaning, por lo que solo estuvo en VM por 48h, posteriormente no fué conflicto.

Neurológico:

El 27/12 durante estadía en UTI evolucionó con compromiso de conciencia, por lo que se solicitó un TAC de cerebro sin contraste y evaluación por neurología, describiéndose en sopor profundo, afasia global, desviación de la mirada a izquierda, hemianopsia por amenaza derecha, PFC derecha, hemiparesia derecha M3, plantar extensor derecho. En TAC de cerebro se observó un infarto lenticuloestriado izquierdo con transformación hemorrágica PH2. Se iniciaron medidas de neuroprotección y se controló con un angioTAC de cuello y cerebro donde se observa ateromatosis en territorio anterior con estenosis en rama M2 izquierda (ateromatosis v/s trombo parcialmente recanalizado). También se solicitó un EEG 30/12 informado con disfunción lenta continua reactivas.

Se inició aspirina con TAC cerebro control 05/01 que mostró estabilidad del sangrado intracraneano, con estabilidad y mejoría de las series hematológicas y estabilidad clínica. Posteriormente se reinició tromboprofilaxis.

Se realizó angioTAC de cerebro de control donde se hace evidente un nido vascular en región insular izquierda sospechoso de una MAV. Se comentó caso, con dr zamora, indica estudio en diferido (primera semana de marzo, dado angiógrafo malo actualmente)

Con contraindicación absoluta de estatinas por antecedente de miopatía necrotizante HMG-coAR (+)

Estudio:

. FRCV: CT 115, LDL 57, HDL 33, TG 125, HbA1c 6.2%, TSH 2.83, VitB12 1266, VDRL NR.

. Holter de ritmo realizado: (P) informe

. Ecocardiografía 09/01: VI° con FSG y segmentaria normal, FE 62%, AI° severamente dilatada, IM leve degenerativa, cavidades derechas normales, PSAP normal, Test burbujas (-) para shunt.

Rehabilitación:

. KNT: TSB independiente y MD con asistencia mínima dado riesgo de caídas por compromiso cognitivo. Sube y baja escaleras con asistencia moderada bilateral. Presenta dificultad para coordinar pasos al bajar.

. FNA: Disfagia leve FILS 7.

Cardiología

En UTAC evolucionó con tendencia a la taquicardia importante y sostenida que impresionó sinusal, aTC tórax (-) para TEP 10/01. TSH en 2.83. Se pensó multifactorial (agitación + deshidratación). Se indicó bisoprolol en dosis bajas con buena respuesta y vigilancia de monitoreo por eventual FA.

Hematología:

Ingresó con pancitopenia, con anemia severa normo-normo, leucopenia y trombocitopenia leve. Fué evaluada por hematología, y se sospechó posible etiología uso de azatioprina vs leucemia.

Estudio:

-Vit B12 1266, Ferritina 1153, SaTF 70%, Bili 1.7 de predominio directo, LDH 280, Fibrinógeno 428, DD 760, Coombs directo (-), Igs normales, hemograma sin formas inmaduras. HTLV (-), VIH (-), VHB (-), VHC (-). EFP plasma sin peak monoclonal, ANA (-). -Estudio autoinmune 2024 negativo.

Tras suspensión de azatioprina en controles de hemograma y perfil hematológico con mejoría progresiva de las 3 series hematológicas, sin necesidad de nuevas transfusiones.

Se interpretó secundario a azatioprina. Se conversó con hematologo Dr. Sandoval, refiere que es esperable que no haya de momento una recuperación sostenida en las series hematológicas y que alteraciones en hemograma actualmente deben ser multifactoriales, por lo que sugirió en control post alta evaluar con exámenes necesidad de derivación para seguimiento por hematología.

Reumatológico:

Paciente con antecedente de miopatía necrotizante Anti HMGCR (+), mantiene movilidad conservada y CK de ingreso 227. Se ha mantenido con azatioprina suspendida, dado la duda de uso de prednisona en ambulatorio, cortisol durante el día en 20. Se

Fecha Última Actualización: 30-01-2026 15:54:01

Página 3 de 4

inició hidrocortisona 50 mg c/8h en contexto de sospecha ISR. Luego se descartó uso crónico, por lo que se comenzó decalaje con plan de suspensión, actualmente en 7.5 mg/día. Reumatología desestimó necesidad de tratamiento por el momento. Se decide control con CK en 3 meses (actual en 37) y en caso de recidiva, iniciar metotrexato.

Infeccioso:

En relación a compromiso de conciencia presentó aspiración, TAC tórax con condensación basal izquierda. Recibió 7 días ampicilina-sulbactam (finalizado 04/01), CAET 29/12 con candida albicans (colonización). Desde el 01/01 con tendencia a la taquicardia, pero afebril, con PPII a la baja, sin nuevo foco infeccioso clínico. TAC TAP control 05/01 con dudoso nuevo foco de condensación basal derecho, CAET 05/01 (+) CGP y candida albicans, recibió fluconazol 3 días, luego suspendido por sugerencia de infectología. Sin nuevas interurrencias.

Gastroenterológico/oncológico:

En TC de ingreso con engrosamiento estenosante de colon sigmoides. Colonoscopia 23/01 con úlcera de la válvula ileocecal, además en colon sigmoides se observa un engrosamiento focal de la mucosa con estenosis, pero de aspecto normal, observando en esta zona una úlcera lineal, de 10 mm, biopsiada, pólipo sésil de ciego reseado, diverticulosis colónica. Con plan de control ambulatorio con rescate de biopsia

Metabólico:

Paciente con antecedente DM2IR, buen control metabólico (HbA1c 6.2%), se mantuvo en seguimiento por diabetes para ajuste de insulino terapia. No ha sido conflicto.

Diagnósticos actuales:

1. Infarto territorio ACM I° (lenticular y fronto-insular)
- Etiología obs embolia central
2. Hematoma intraparenquimatoso obs secundario a MAV insular izquierda
3. Pancitopenia secundaria a mielosupresión por Azatriopina, en recuperación
4. Delirium hiperactivo en recuperación
5. Colitis segmentaria v/s neoplasia epitelial de colon sigmoides, biopsiada
6. Antecedentes: HTA, DM2 IR, Dislipidemia, Miopatía necrotizante Anti HMGCR (+)

INDICACIONES DE ALTA

Rehabilitación: Kine + TO + fono

Diagnóstico de Egreso

Infarto Cerebral -
Diabetes mellitus 2 -
Encefalopatía toxica metabólica -
Pancitopenia en estudio -
Lesión Colónioca En Estudio -
Miopatía Anti Hmgcoa -

Condición de Egreso Alta Otro Destino

Egreso con Catéter Doble J:NO

Vigil espontánea
Mucosas rosadas e hidratadas
Llene capilar < 3 seg.
RRTSS, MP (+) SRA
Abdomen BDI, sin signos de irritación peritoneal. RHA (+)
EEII sin edema, sin signos de TVP.

Examen neurológico:

Vigil espontánea, muy inatenta, conecta con examinador de manera intermitente, nomina 3/5, repite 2/3, obedece órdenes simples por imitación, parafasias, disartria moderada, hipofonía.

RFM (+), pupilas isocóricas, CV conservado por amenaza. OCM conservada, sin asimetría facial. Pares bulbares sin alteraciones.

Trofismo disminuido, paratónica, M4+ hemicuerpo izquierdo, m4 braquial derecho, M3+ crural derecho. ROT conservados. Sin movimientos anormales

Fecha Epicrisis : 30/01/2026 15:54

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 30-01-2026 15:54:01

Página 4 de 4

Sensitivo refiere conservado
Cerebeloso impresiona conservado

NIHSS 8

Plan Post Alta

Reposo relativo asistido
Régimen 200 gr de Hidratos de Carbono. Licuado con Líquidos espesos con almidón
Rehabilitación por Fonoaudiología, Kinesiología

Insulina NPH 20 unidades AM y 10 unidades PM, vía subcutánea
- Insulina cristalina cada 6 horas según HGT:
menos de 180: nada
180-220: 2
221-260: 4
261 o más: 6

Ácido acetilsalicílico 100 mg al día vo
Ácido Fólico 1 mg al día vía oral
Bisoprolol 2.5 mg al día
Omeprazol 20 mg al día
Polietilenglicol 15 gramos en 200 cc de agua espesada cada 12 horas
Prednisona 5 mg al día hasta el día 3 de febrero incluido y luego suspender
Risperidona 1 mg en la noche
Sertralina 50 mg al día
Melatonina 3 mg /noche
Elcald forte 1 al día

Control con Neurología CDT (dejo IC)
Control con Dr Zamora (Neurocirugía CDT hora post hospitalización) marzo
Control con coloproctología (IC)
Control con Reumatología (IC)
Control con Diabetes (IC)
Control hematología (IC)
Control en CESFAM correspondiente para seguimiento por atención domiciliar / programa de postrados
Consultar nuevamente en servicio de urgencia en caso de síntomas de alarma (se educa).

Indicaciones

Tipo de Reposo :

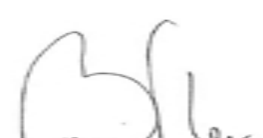
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO


Bec. Sebastián Sánchez Zagal
Becado/Residente


Bernardita María Soler León
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 30/01/2026 15:54

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Miércoles, 25 de Marzo de 2026 23:47

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar